PORT FOLIO



ญาณภัทร พินิจพิชิตกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

Overview (1/2)

1 · Research & Publications

• First author (Under review) — Maternal & neonatal outcomes according to gestational age at PPROM before 28 weeks · Division of MFM, Siriraj

• Co-author (Under review) — Long-term continuation & predictors of LNG-IUS expulsion in benign gynecologic disorders · Gynecologic Endocrinology Unit, Siriraj

• ALBI Score as a novel predictor for hepatocellular carcinoma in non-cirrhotic chronic hepatitis B carrier · GI & Liver Center, Siriraj — คัดเลือก Oral Presentation, Siriraj Research Day

• Ongoing Thesis (CMMU) — Business model for holistic rehabilitation and PT B2B office syndrome solution · อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ธนพล วีราสา

• คณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

2 · Innovation & Entrepreneurship

• PODIPATCH — Co-founder & Team Leader · microneedle พร้อม integrated wound care สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า

• TRAWELL — Co-founder & CEO (เม.ย. 2564–ปัจจุบัน) · Health Travel Tech Startup ระยะ Ideation

• UNITE — Co-founder & CEO (ม.ค. 2563 – พ.ค. 2566) · Edtech Startup ระยะ Prototype, Full-stack developer

• Management & Product Design Internship, NIRVAMED (พ.ค. 2567–ปัจจุบัน) · Lean Management + Catheter / contrast removal system

• Back-End Developer Internship, MonkeyEveryday Co., Ltd. (ม.ค.–มิ.ย. 2563) · MySQL, Learning Behavior Tracking

• 42 Bangkok Cadet (มิ.ย. 2564 – มิ.ย. 2569) · 1 ใน 120 คนแรกที่ผ่าน Piscine จากผู้สมัครกว่า 10,000 คน

• Medcubator 2022 Pre-Incubation Program by TMSIC

• MSEC II 2022 Incubation Program by Mahidol Startup Club

• Finance Team, Thai Medical Student Innovation Club (TMSIC) 2565

• Grand Finalist, Medical Grand Challenge Competition, NUS สิงคโปร์ (เม.ย.–17 ส.ค. 2567) — Podipatch

• ชนะเลิศ MDCU Pitching Challenge (เม.ย. 2568) · รางวัล 30,000 บาท — Podipatch

• ชนะเลิศ UNIHACK 2021 · Hackathon Competition by Chula Tech Startup — UNITE

• Qualified to pitch, Startup Thailand League Regional Pitch & Demo Day · Top 5 ม.มหิดล · ทุน NIA 25,000 บาท — Trawell

• Grand Finalist, CU Case Discovery 2022 (20 ทีม จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 200+ ทีม)

• รองอุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร & ประธานฝ่ายเทคโนโลยี, สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช 2567

• ประธานจัดงาน Road to MedTech Career Path Conference (ต.ค. 2567)

• หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร (Startup Team) สโมสรฯ 2565 · MC งาน Research x Startup Talk (16 ก.ค. 2565) · Head of Facilitator, Siriraj-RISE Hackathon (23-24 ก.ค. 2565)

3 · Leadership — SIOGC (Siriraj Obstetrics & Gynecology Club)

• ประธาน (President) และผู้ก่อตั้ง (Founder), Siriraj Obstetrics and Gynecology Club · มิ.ย. 2567–ปัจจุบัน

• SIOGC First Meet 2568 — ประธานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม

• SIOGC Workshop (4 สถานี) 2568 — ประธานควบคุมดูแลการจัดบูธกิจกรรม

• Siriraj Open House Booth 2568 — ประธานควบคุมดูแลการจัดบูธกิจกรรม

• งานเบิกฟ้าชมรม 2568 — ประธานควบคุมดูแลการจัดบูธกิจกรรม

• Resident Playbook Movie Night 2568 — ประธานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม

• แคมเปญเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2568 — ประธานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม

• กิจกรรม LGBTQ+ Awareness 2568 — ประธานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม

• Pride Month Movie Night 2568 — ประธานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม

• HPV Self-Test Community Project ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2568 — ประธานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม

• ผู้ก่อตั้งหน่วยวิจัยนักศึกษาแพทย์ด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (OB/GYN Student Research Club Unit)

Outline — สารบัญผลงาน (2/2)

จัดกลุ่มตามธีมของพอร์ตโฟลิโอ · รวม 76 รายการ

4 · Global Health

- รองประธาน (VP) และผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founder), Siriraj Global Health Club · 2566–ปัจจุบัน
- รองประธาน Global Health Case Competition 2024 (PMAC 2024 side-event) · ส.ค. 2567–ก.พ. 2568
- ประธานคัดเลือกตัวแทน & เข้าร่วม Indo-Pacific Global Health Case Competition, Univ. of Melbourne · ก.ย. 2567
- กรรมการ Global Health Capacity Building (CU x RA x SI) · 5 ต.ค. & 9 พ.ย. 2567
- ผู้ริเริ่มโครงการ Health Management Elective, Global Health Elective Unit
- Observer, PMAC 2025 — "Harnessing Technology in an age of AI to build healthier world"
- Observer, PMAC 2026 — "Youth for Equitable Health in a Changing Demographic World"
- Global Health & Management Elective — สสจ.พิจิตร · 9-22 ก.พ. 2568
- ศึกษาดูงาน BDMS — PMAC Field Trip "Exploring AI healthcare ecosystem in Thailand" · 30 ม.ค. 2568

5 · International & Clinical Electives

- Clinical Exchange (OB/GYN, pending), Duke University, USA · 5-30 เม.ย. 2570 (ตัวแทนศิริราช)
- Clinical Exchange, Orthopedic & Plastic Surgery, NUH, NUS สิงคโปร์ · 24 ก.พ.-21 มี.ค. 2568
- Public Health Internship (HPV vaccination ลาว), Saw Swee Hock SPH, NUS · 21 ก.พ.-7 มี.ค. 2567
- IFMSA Research Exchange Program, Aix-Université, Marseille ฝรั่งเศส · 1 เม.ย.-10 พ.ค. 2566
- Lore-Out Research Exchange Selection Team, SCORE IFMSA · 2566
- OB/GYN Elective — มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ · 2-13 มี.ค. 2569
- OB/GYN Elective — มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ · 30 มี.ค.-10 เม.ย. 2569
- OB/GYN Elective — ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก · 18-30 ต.ค. 2569
- OB/GYN Elective — คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล · 16-27 มี.ค. 2569

6 · Conferences & Academic

- Observer, ตัวแทน SIORS ในงาน 46th RCOST Annual Meeting · 17-19 ต.ค. 2567
- เข้าร่วมงานประชุม 33rd Congress of the Thai Society for Reproductive Medicine (TSRM) · 9-12 มี.ค. 2569
- สัมมนา "Infertility Management: Clinical updates and evidence-based practice" RTCOG · 22 ส.ค. 2569
- สัมมนา "More than a scar: Understanding Cesarean scar defect" RTCOG · 22 ส.ค. 2569
- สัมมนา "Reproductive Medicine Conference ครั้งที่ 22" RTCOG · 30 ต.ค. 2568
- สำเร็จหลักสูตร Obstetrics & Gynecology for General Practitioners, CMU E-learning

7 · Community Service & Volunteer

- รางวัลผลงานโดดเด่น Clip VDO สอนฉีดอินซูลิน — สังขละบุรี 2568
- เลขานุการ คณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 4 · 2566-2569
- สมาชิกฝ่ายกิจกรรม Nice to Meet (Sala)ya · 2565
- สมาชิกฝ่ายกิจกรรม Siriraj Family Concert · 2566
- สมาชิกฝ่ายกิจกรรม รับน้องข้ามฟาก · 2566
- HPV Self-Test Community Project ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ · 2568
- คณะผู้จัดทำ VDO ส่งเสริม HPV Screening ร่วมกับ อ.ปนิชา · 2568
- ผู้ริเริ่มและกรรมการ Issara Project — Hypertension Screening ชุมชนคลองเตย · 2568
- คลิปสอนฉีดอินซูลิน 3 ภาษา — สังขละบุรี · 2568
- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ — ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านดอนยาง สังขละบุรี · 2568
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนกองม่องทะ — สังขละบุรี · 2568
- ร่วมรณรงค์หยุดเผาป่า ลดฝุ่นควัน — ท่าฬ่อ พิจิตร · 2568
- พูดให้แรงบันดาลใจ — รร. บ้านท่าร่อ พิจิตร · 2568
- อาสาสมัคร CPR/BLS "ปั๊มเหอะพี่ขอ" · 2568

8 · Academic Olympiads

- เหรียญทองแดง IPhO ครั้งที่ 50 · Tel Aviv อิสราเอล · 2562
- Honorable Mention APhO ครั้งที่ 20 · Adelaide ออสเตรเลีย · 2562
- เหรียญทองแดง IAO ครั้งที่ XXII · Weihai จีน · 2560
- เหรียญทอง Thailand Physics Olympiad ครั้งที่ 17 · 2561
- เหรียญทอง อันดับ 2 Thailand Astronomy Olympiad ครั้งที่ 14 · ม.นเรศวร · 2560

Research & Publications

Overview

2566

เข้าร่วมคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ฝ่ายวิชาการ เริ่มต้นเส้นทางงานวิจัยทางคลินิก

2568–ปัจจุบัน

ผลงานวิจัย 3 เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ ร่วมกับภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

> “งานวิจัยทุกชิ้นทำร่วมกับคณาจารย์และหน่วยงานของศิริราช”

4
Research Projects

3
Departments Involved

1
Oral Presentation Selected

งานวิจัยของผมเน้นการศึกษาทางคลินิกในสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตั้งแต่การคลอดก่อนกำหนดคลอด การประเมินองค์กรคุมกำเนิดมะเร็ง ไปจนถึงการคงอยู่ของห่วงคุมกำเนิด การทำงานร่วมกับอาจารย์และทีมสหวิชาชีพสอนให้ผมเห็นคุณค่าของการตั้งคำถามที่ดีก่อนหาคำตอบ และการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

Key Research Highlights

1. First Author — Maternal & Neonatal Outcomes at PPROM <28 wks

Under review · Division of Maternal-Fetal Medicine, Siriraj
Role: ออกแบบกรอบเก็บข้อมูลย้อนหลัง ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียน วิเคราะห์ทางสถิติ และเขียนต้นฉบับบทความในฐานะผู้นิพนธ์หลัก

2. Co-Author — LNG-IUS Long-term Continuation & Expulsion Predictors

Under review · Gynecologic Endocrinology Unit, Siriraj
Role: ร่วมเก็บข้อมูลผู้ป่วยและสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติร่วมกับทีมวิจัยหลัก

3. ALBI Score as a Novel Predictor for HCC

Selected Oral Presentation, Siriraj Research Day · GI & Liver Center
Role: ร่วมเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย
Presented at: Siriraj Research Day 2568 — Selected Oral Presentation

4. MSc Thesis (CMMU) — Business Model for Holistic Rehabilitation

Ongoing · PT B2B Office Syndrome Solution
Role: ออกแบบโมเดลธุรกิจ วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง และพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับโซลูชันฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม

PodiPatch: Smart Microneedle-Integrated Dressing for Diabetic Foot Ulcers

Co-founder & Team Lead — Ideation Stage

🏆 Grand Finalist, NUS Medical Grand Challenge 2024

International health-tech pitching competition, National University of Singapore



🏆 Winner, MDCU Pitching Challenge 2025

Innovation Concept Pitching, hosted by Innovation Center (CMICe), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University



สิ่งที่ได้เรียนรู้ — What I took from it

จากงาน Grand Finalist ที่ NUS สู่รางวัลชนะเลิศที่ MDCU Pitching Challenge สะท้อนพัฒนาการของไอเดีย PodiPatch จากต้นแบบแรกจนถึงการนำเสนอที่แข็งแกร่งขึ้นในเวทีระดับประเทศ

PodiPatch — Smart Microneedle Sensor & Drug-Delivery Patch

Co-Founder & Team Lead — Ideation Stage with Feasibility Analysis

What is PodiPatch?





PodiPatch — a microneedle-based sensor & drug-delivery patch for diabetic foot ulcers.

PodiPatch เป็นแผ่นแปะที่ผสานเซนเซอร์ไมโครนีดเดิลเข้ากับระบบนำส่งยา สำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรังจากเบาหวาน ตัวเซนเซอร์วัดค่าที่บ่งชี้สถานะของแผล เช่น ระดับการอักเสบและตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อประเมินระดับการรักษาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันระบบนำส่งยาสามารถปล่อย growth factor คอลลาเจน หรือสารต้านจุลชีพ เพื่อกระตุ้นการสมานแผล

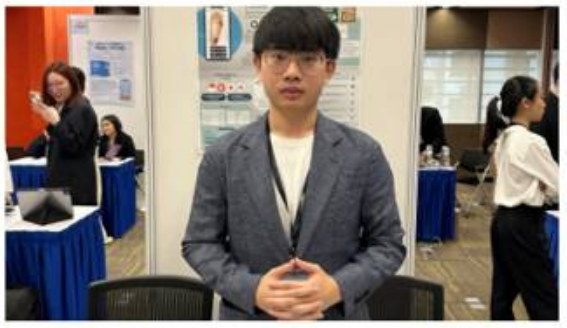
Awards & Recognition

🏆 Grand Finalist, NUS Medical Grand Challenge 2024

International health-tech pitching competition, National University of Singapore







🏆 Winner, MDCU Pitching Challenge 2025

Innovation Concept Pitching, hosted by Innovation Center (CMICe), Chulalongkorn University





SECTION 3 · สิ่งที่ได้เรียนรู้ — What I Took From It

จุดเริ่มต้นของ PodiPatch มาจากตอนขึ้นวอร์ดปี 4 ที่พบผู้ป่วยแผลเรื้อรังจากเบาหวานจำนวนมาก หลายรายต้องถูกตัดขา แม้วิธีรักษาปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพดี แต่ผู้ป่วยจำนวนมากยัง compliance ไม่เพียงพอ จนแผลลุกลามกระทบชีวิตประจำวันอย่างรุนแรง

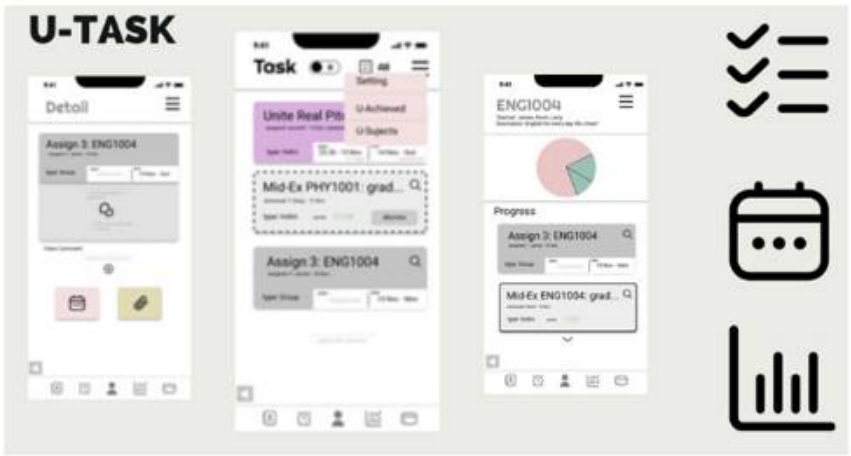
ระหว่างเข้าค่าย Medcubator ปี 1-2 ได้พบอาจารย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ จุฬาฯ ที่ทำวิจัยเรื่อง microneedle (ปกติใช้ในกลุ่ม skincare) จึงเห็นว่าคอนเซปต์นี้น่าจะประยุกต์กับแผลเรื้อรังได้ เป็นจุดที่ผมเริ่มก่อตั้งไอเดียนี้ขึ้นเอง ในฐานะ Co-founder และ Team Lead ผมนำทีมเข้าแล็บอาจารย์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ และนำเสนอที่ NUS สิงคโปร์และจุฬาฯ จนได้ Grand Finalist และ Winner

ตอนนี้โปรเจกต์อยู่ในช่วง feasibility analysis ที่หยุดพักไปบ้างเพราะภาระการเรียน แต่ประสบการณ์นี้สอนให้เห็นว่าปัญหาคลินิกที่เจอหน้างานจริงนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมได้ และทำให้ผมอยากเป็นแพทย์ที่มองหาวิธีที่ดีกว่าเดิมให้ผู้ป่วยอยู่เสมอ

UNITE — AI-Powered Educational Platform for Medical Students

Founder & Team Lead — Prototype Stage

SECTION 1 · รายละเอียดผลิตภัณฑ์ — What is UNITE



UNITE — an AI-powered educational platform for medical students.

UNITE เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาแบบครบวงจรสำหรับนักศึกษาแพทย์ ใช้ AI ช่วยจัดการตารางเรียน การบ้าน และสื่อการเรียน โดยรวบรวมแหล่งข้อมูลอย่าง Lecturio, PubMed และ AMBOSS ไว้ในแอปเดียว แบ่งเป็นสายพรีคลินิกและคลินิก พร้อมระบบฟีดแบ็กแบบเรียลไทม์ที่ติดตามทั้งคะแนนสรุปผลและคะแนนระหว่างทาง เพื่อแนะนำเนื้อหาที่เหมาะกับจุดอ่อนและสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

SECTION 2 · รางวัลและความสำเร็จ — Awards & Recognition

🏆 Winner, UniHack Hackathon 2021

Hosted by Chula Tech Startup, Chulalongkorn University





SECTION 3 · สิ่งที่ได้เรียนรู้ — What I Took From It

UNITE เป็นไอเดียที่ผมริเริ่มขึ้นเองเป็นหลัก ต่างจาก PodiPatch ที่เป็นการร่วมก่อตั้งกับทีม ในฐานะ Founder และ Team Lead ผมรับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบคอนเซปต์แพลตฟอร์มไปจนถึงลงมือเขียนโค้ดเองในฐานะ full-stack developer ช่วงแรก

UniHack เป็นสนามแข่งขันด้านเทคโนโลยีสนามแรกที่ผมได้เข้าร่วม ภายใน 48 ชั่วโมงต้อง refine ไอเดียร่วมกับเพื่อนในทีม ลงมือสร้างโปรโตไทป์จริง ตั้งแต่ทำ Photoshop mockup ทดสอบระบบ ลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล้า จนสุดท้ายได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประสบการณ์นี้สอนให้เห็นว่าการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันเวลาที่จำกัดต้องอาศัยการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน — ทักษะที่ผมนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดการขึ้นวอร์ดตั้งแต่นั้นมา

PodiPatch — จากวอร์ดสู่ห้องแล็บ

HIGHLIGHT PROJECT · Innovation & Entrepreneurship · Co-Founder & Team Lead

ตอนขึ้นวอร์ดปี 4 ผมเจอผู้ป่วยแผลเรื้อรังจากเบาหวานเยอะมาก หลายรายลงเอยที่การตัดขา สิ่งที่ติดอยู่ในหัวตอนนั้นไม่ใช่เรื่องวิธีการรักษา

“ไม่ใช่ว่าเราไม่มีวิธีรักษาที่ดีพอ — แต่ผู้ป่วยจำนวนมากทำตามแผนการรักษาไม่ได้จริง”

จุดเชื่อมเกิดขึ้นตอนเข้าค่าย Medcubator ปี 1–2 ที่ได้เจออาจารย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ จุฬาฯ ซึ่งทำวิจัย microneedle — เทคโนโลยีที่ตอนนั้นใช้กันแค่ในวงการ skincare ผมเห็นว่าถ้าเอามาใช้กับแผลเรื้อรังได้ มันจะแก้ปัญหา compliance ที่ต้นเหตุ เพราะแผ่นแปะทำงานเองโดยผู้ป่วยไม่ต้องจำอะไรเลย

ไอเดียนี้ผมเป็นคนตั้งต้นเอง ในฐานะ Co-founder และ Team Lead ผมนำทีมเข้าแล็บอาจารย์เพื่อทำ feasibility analysis ออกแบบให้เซนเซอร์ไมโครนีเดิลวัดระดับการอักเสบของแผล แล้วปล่อย growth factor คอลลาเจน หรือสารต้านจุลชีพตามที่แผลต้องการ

เราเอาไป pitch ที่ NUS สิงคโปร์ ได้ Grand Finalist, NUS Medical Grand Challenge 2024 และที่จุฬาฯ ได้ Winner, MDCU Pitching Challenge 2025

ตอนนี้โปรเจกต์หยุดพักที่ช่วง feasibility เพราะภาระการเรียน แต่สิ่งที่ได้กลับมาไม่หายไปไหน

KEY MESSAGE

ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับนวัตกรรม ไม่ได้อยู่ในเปเปอร์ แต่อยู่ตรงหน้าเราตอนราวด์วอร์ด

และผมอยากเป็นแพทย์ที่ไม่หยุดถามว่า “มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม”

Trawell — Health-Focused Travel Planning Platform

Founder & CEO — Ideation Stage with Feasibility Analysis

SECTION 1 · รายละเอียดผลิตภัณฑ์ — What is Trawell





Trawell — a health-focused travel planning platform for patients and wellness tourists.

Trawell เป็นแพลตฟอร์มวางแผนการเดินทางเชิงสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำหัตถการหรือหาคลินิกเวลเนสระหว่างเดินทาง มีฟีเจอร์ค้นหาคลินิก สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหารระหว่างทาง ช่วยเจรจาต่อรองประกันสุขภาพให้ได้ราคาที่ดีขึ้น พร้อมเครือข่ายแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา และระบบรับประกันบริการพร้อม feedback ติดตามผล รวมถึงการจ่ายยาผ่านระบบเทเลเมดิซีน

SECTION 2 · รางวัลและความสำเร็จ — Awards & Recognition

🏆 Qualified, Startup Thailand League Regional Pitch & Demo Day 2022

Awarded Top 5 Finalist, Mahidol University Startup Thailand League Competition







SECTION 3 · สิ่งที่ได้เรียนรู้ — What I Took From It

จุดเริ่มต้นของ Trawell มาจากประสบการณ์ส่วนตัวในการวางแผนเดินทางให้คนในครอบครัวที่มีโรคประจำตัว ต้องประสานทั้งเรื่องนัดหมายแพทย์ การเดินทาง ที่พัก และการดูแลต่อเนื่องระหว่างทาง ซึ่งยุ่งยากและกระจัดกระจายมาก — ไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ในฐานะ Founder และ CEO ผมเป็นเจ้าของไอเดียและนำทีมพัฒนา Trawell ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวางแผนการเดินทางแบบครบวงจร ตั้งแต่หาคลินิก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารระหว่างทาง ไปจนถึงเจรจาต่อรองประกันสุขภาพให้ได้ราคาดีที่สุด ร่วมกับเครือข่ายแพทย์ทุกสาขาเพื่อบริการที่มีคุณภาพและแข่งขันได้ พร้อมระบบรับประกันบริการและ feedback loop สำหรับติดตามผล รวมถึงการจ่ายยาผ่านระบบเทเลเมดิซีน

การนำ Trawell ไป pitch ในเวที Startup Thailand League ที่มหิดล สอนให้เห็นความสำคัญของการเล่าปัญหาที่จับต้องได้จากประสบการณ์จริง มากกว่าการนำเสนอฟีเจอร์เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว และทำให้ผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ดีที่สุดมักเริ่มจากการเข้าใจความยากลำบากของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างแท้จริง

Nirvamed — Innovation & Technology Internship

Management & Product Design Intern — May 2024–present

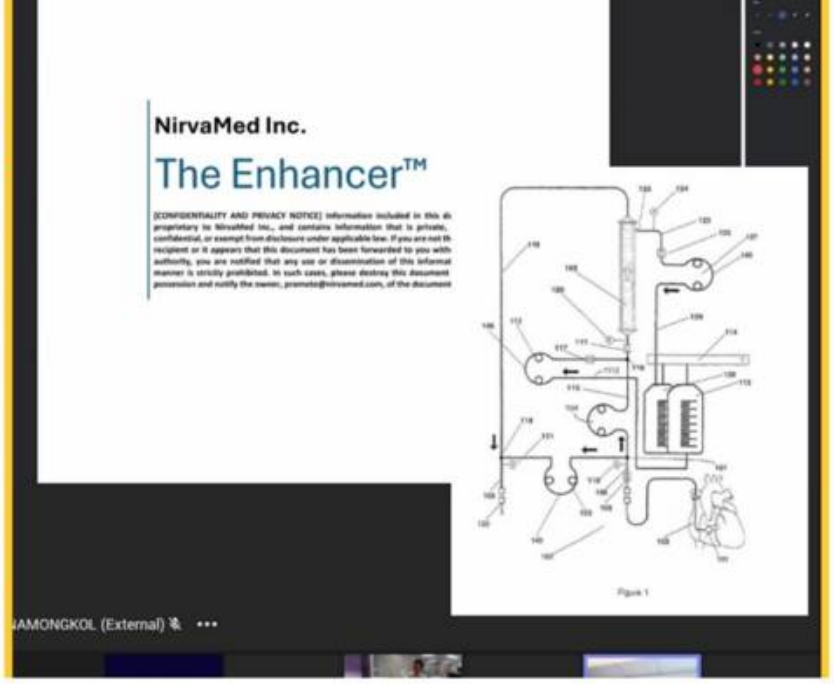
🏆 Product Development — Catheter Testing & "The Enhancer"

Lean management and product development for a medtech/catheter startup









สิ่งที่ได้เรียนรู้ — What I took from it

การฝึกงานที่ Nirvamed เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าได้เติบโตมากที่สุดในชีวิตนักศึกษาแพทย์ของผม เพราะได้ทำงานทั้งด้านธุรกิจและนวัตกรรมไปพร้อมกันจริงๆ ไม่ใช่แค่ทฤษฎี ทำให้เห็นทั้งข้อจำกัดของการระดมทุนด้าน medtech ในประเทศไทย และเห็นว่ามีวิธีฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นได้ เป็นบทเรียนที่ผสมผสานมุมมองทางธุรกิจและทางคลินิกเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง

อีกส่วนที่ได้ใช้ความรู้ทาง engineering โดยตรงคือการออกแบบระบบ contrast removal และลงมือทดลองเองในแล็บจนได้เห็นข้อมูลจริงจากการทดสอบ ไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษ และสิ่งที่ทำให้ประสบการณ์นี้มีความหมายที่สุดคือการได้ลงมือทำในบริษัทจริงที่มี high stake มีเงินลงทุน มี deadline และความรับผิดชอบสูง ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการขอ US FDA approval และการจดสิทธิบัตร US patent ทำให้เห็นจริงๆ ว่ากว่าจะผลิต medical technology ออกมาได้ 1 ชิ้นต้องผ่านอะไรบ้าง และทำให้ความฝันไม่ได้ดูเป็นแค่ความฝัน แต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง

Nirvamed — Cardiac Contrast-Removal MedTech

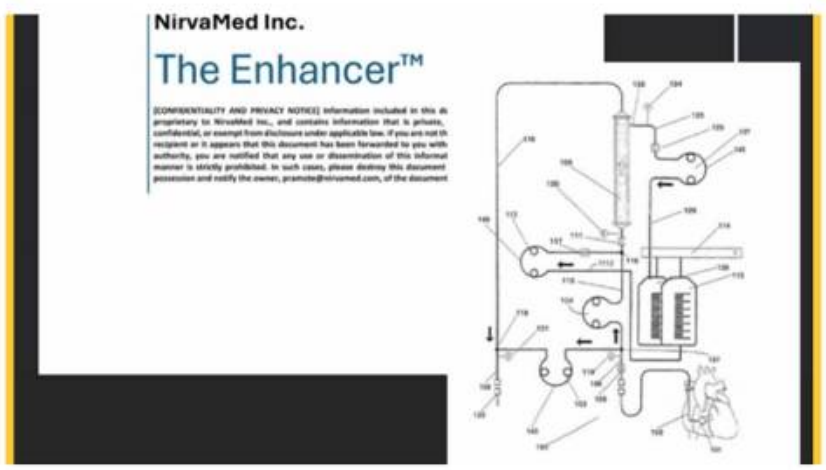
Business & Product Design Intern — May 2024–Present

SECTION 1 · Nirvamed คือใคร — What is Nirvamed & My Role









Nirvamed is a medtech startup developing ContraMove, a catheter-based technology that traps contrast media within the heart during cardiac procedures. Founded by Dr. Pramote Hor-charoen, Siriraj alumnus.

SECTION 2 · รายละเอียดงานที่ทำ — What I Did

ในฐานะ Business & Product Design Intern ผมรับผิดชอบ 2 ด้านหลัก

ด้านธุรกิจ นำประสบการณ์จากปริญญาโทและการทำ Trawell/UNITE มาใช้จริงในการระดมทุนจากนักลงทุนและกลุ่มกองทุนต่างๆ ทำสไลด์พิตช์ และวางแผนธุรกิจระยะยาวให้บริษัท

ด้านผลิตภัณฑ์ ศึกษาเทคโนโลยี contrast removal จากต่างประเทศ พูดคุยกับบริษัทเทคโนโลยี Hemoadsorption เช่น Jafron จากประเทศจีนและปรึกษาอาจารย์วิศวกรรมและอาจารย์ด้าน interventional cardiology จากหลายสถาบัน เพื่อช่วยออกแบบเทคโนโลยี ContraMove ให้ดักจับสารทึบรังสีในหัวใจไม่ให้ไปทำร้ายไต ซึ่งเป็นปัญหาจริงที่คนไข้โรคหัวใจร่วมกับโรคไตเรื้อรังจำนวนมากเผชิญอยู่

SECTION 3 · สิ่งที่ได้กลับมา — What I Took From It

การฝึกงานที่ Nirvamed เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าได้เติบโตมากที่สุดในชีวิตนักศึกษาแพทย์ของผม เพราะได้ทำงานทั้งด้านธุรกิจและนวัตกรรมไปพร้อมกันจริงๆ ไม่ใช่แค่ทฤษฎี ทำให้เห็นทั้งข้อจำกัดของการระดมทุนด้าน medtech ในประเทศไทย และเห็นว่ามีวิธีฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นได้ เป็นบทเรียนที่ผสมผสานมุมมองทางธุรกิจและทางคลินิกเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง

Technology Leadership — Siriraj Medical Student Union

รองอุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคคล สายเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช (สพศ.)

Overview

ปีที่ 2 (2565)
- สมาชิกฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาบุคคล
- เสนอไอเดียและเป็น Head of Facilitator, Siriraj Hackathon
  - MC, Research x Startup talk

ปีที่ 4 (2567)
- รองอุปนายกด้านเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาบุคคล
- จัดงาน Road to MedTech Career Path in Healthcare
- Content Creator, IG Personal Development SMSU Siriraj

🧑‍💻 นศพ. ปี 2 (2565) — Siriraj Hackathon

ตอนปี 2 เข้าเป็นสมาชิกฝ่ายเทคโนโลยีของฝ่ายพัฒนาบุคคล สพศ. ศิริราช ปีนั้นเป็นปีแรกที่มีผ่ายพัฒนาบุคคล ผมเป็นรุ่นน้องปี 2 ที่มี Background ในการแข่งขัน Hackathon จึงเสนอไอเดียที่จะจัด Hackathon ด้าน healthcare innovation ให้นักศึกษาแพทย์ และรับหน้าที่เป็น Head of Facilitator ดูแลทีมพี่เลี้ยงที่คอยช่วยกลุ่มผู้เข้าแข่งขันตลอดงาน งานนี้ได้เชิญผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ และ CEO ของ THE STANDARD มาเป็นวิทยากร



- ออกแบบโครงสร้างกิจกรรมและ timeline การแข่งขันร่วมกับทีมงาน
- คัดเลือกและอบรมทีม facilitator ก่อนวันงานจริง
- วางแผนธีมงานและติดต่อประสานงานวิทยากรระดับผู้บริหารและผู้ว่าฯ





🏆 ปีที่ 4 (2567) — Road to MedTech Career Path in Healtcare

พอขึ้นปี 4 ได้รับเลือกเป็นรองอุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคคล สายเทคโนโลยี รับผิดชอบงานฝ่ายเทคโนโลยีทั้งหมดของ สพศ. งานใหญ่ที่สุดของปีนั้นคือการจัดงาน Road to MedTech Career Path in Healthcare เพื่อเปิดมุมมองอาชีพสาย health-tech ให้รุ่นน้อง ได้ติดต่อเชิญวิทยากรที่เป็น Technolgy expert แต่มี Medical Career path ที่แตกต่างกันทั้ง 3 สาย ได้แก่ Clinical practice: ผศ. นพ. วรัชญ์ วรนิสรากุล ,Medical startup: ดร. ปราโทย์ หอเจริญ, Research: ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

- ประธานจัดงานและควบคุมดูแลภาพรวมของกิจกกรม
  - วางแผนธีมงานและติดต่อประสานงานอาจารย์วิทยากรทั้ง 3 ท่าน
- บริหารทีมฝ่ายเทคโนโลยีและงบประมาณของกิจกรรม
- ดูแล content การให้ความรู้ผ่าน IG Personal Development SMSU Siriraj ควบคู่กันไป

Innovation & Technology — Startup Ecosystem

Additional Ventures & Coding Background

🏆 Member, Medcubator — Startup Incubator by TMSIC (2021)

1-year startup incubator program by Thai Medical Student Innovation Club (TMSIC), pairing medical students with mentors to turn a healthcare idea into a working concept and pitch







🏆 Selected, 42 Bangkok Cadet (2021)

1 of 120 selected out of 10,000 applicants for the Piscine — an intensive, peer-to-peer coding bootcamp with no teachers or lectures, based on 42's project-based curriculum



Innovation & Entrepreneurship — Additional Activities

กิจกรรมและบทบาทเสริมที่ยังไม่มีภาพประกอบ

กิจกรรมเพิ่มเติม — Additional Ventures & Roles

MonkeyEveryday — Back-End Dev (2563)
พัฒนาฐานข้อมูล MySQL และระบบ Learning Behavior Tracking ให้แพลตฟอร์ม Edtech

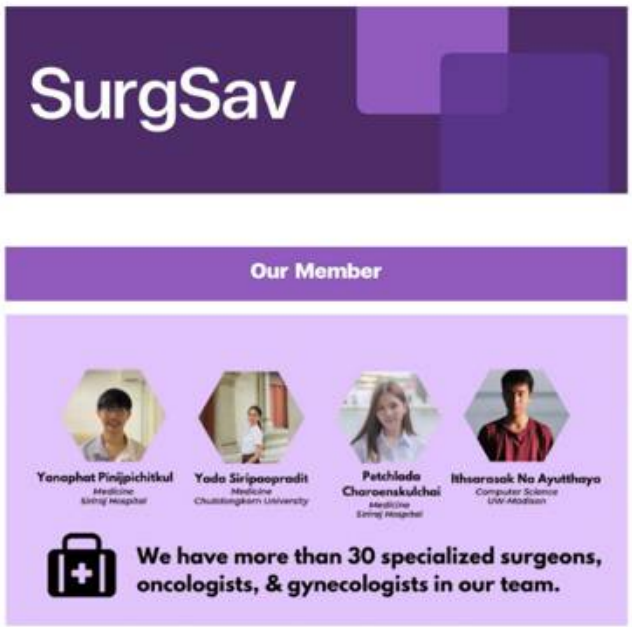
MSEC II Incubation Program (2565)
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ by Mahidol Startup Club

Finance Team, TMSIC (2565)
ร่วมทีมการเงินของ Thai Medical Student Innovation Club

CU Case Discovery — Open qualifier (2565)
ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 200+ ทีม

MC, Research x Startup Talk (2565)
พิธีกรงานเสวนา จัดโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช

CU Case Discovery — Open qualifier (2565)
ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 200+ ทีม







SIOGC — จุดเริ่มต้นของชมรม

President & Founder — ก่อตั้งและวางระบบชมรมตั้งแต่ศูนย์ (2567–ปัจจุบัน)



ตอนปี 4 ผมเห็นว่าศิริราชยังไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาแพทย์ที่สนใจสูติ-นรีเวชได้มารวมตัวกัน แลกเปลี่ยนความรู้ หรือรู้จักอาจารย์ในภาควิชานอกเหนือจากตอนขึ้นวอร์ด เลยชวนเพื่อนกลุ่มเล็กๆ มาคุยกันว่าอยากทำแบบนี้ไหม จากนั้นเริ่มวางโครงสร้างชมรมทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์ — vision, mission ไปจนถึงแบ่งทีมงานเป็น 8 ฝ่าย พร้อม workflow ที่ชัดเจนตั้งแต่ initiate event ไปจนถึง final evaluation

ส่วนที่ยากที่สุดไม่ใช่การคิดไอเดียกิจกรรม แต่คือการออกแบบระบบให้ชมรมอยู่ได้ต่อแม้ไม่มีผมแล้ว ต้องคิดเรื่อง succession plan และความยั่งยืนทางการเงินตั้งแต่วันแรก

สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจทำตั้งแต่ต้นคือให้ SIOGC เป็นพื้นที่เปิดกว้างจริงๆ ไม่ใช่แค่วิชาการ — เลยตั้งฝ่าย LGBTQ+ ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อจัด Pride month และโปรโมท SI-pride clinic เพราะอยากลบภาพจำว่าศิริราช conservative

ปีแรกของชมรม (2567–2568) มีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ First Meet เปิดตัวชมรม ไปจนถึง Workshop หัตถการพื้นฐาน พานักศึกษาเข้าดูงานใน OR จริง กิจกรรม Pride month และปิดท้ายด้วยงานวิชาการที่เชิญวิทยากรต่างประเทศ — แต่ละงานเป็นก้าวเล็กๆ ที่ต่อกันจนชมรมมีตัวตนจริง ไม่ใช่แค่ไอเดียในหัวอีกต่อไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้ — What I Took From It

การก่อตั้งชมรมสอนเรื่อง systems thinking มากกว่าที่คิด — ไม่ใช่แค่จัดงานให้สนุก แต่ต้องออกแบบให้ระบบเดินต่อได้เองในระยะยาว

SIOGC — จุดเริ่มต้นของชมรม

President & Founder — ก่อตั้งและวางระบบชมรมตั้งแต่ศูนย์ (2567–ปัจจุบัน)

ตอนปี 4 ผมเห็นว่าศิริราชยังไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาแพทย์ที่สนใจสูติ-นรีเวชได้มารวมตัวกัน เลยชวนเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ก่อตั้ง SIOGC และวางโครงสร้างชมรมทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์ — ตั้งแต่ vision, mission ไปจนถึงระบบทีมงานที่ชัดเจน ดังผังด้านล่าง

✦ โครงสร้างทีมงาน 8 ฝ่าย ที่ออกแบบเอง

President

Obstetrics	Events	Facilitating	Coordinating
Management	PR	General Issue	LGBTQ+

ส่วนที่ยากที่สุดไม่ใช่การคิดไอเดียกิจกรรม แต่คือการออกแบบระบบให้ชมรมอยู่ได้ต่อแม้ไม่มีผมแล้ว ต้องคิดเรื่อง succession plan และความยั่งยืนทางการเงินตั้งแต่วันแรก ส่วนฝ่าย LGBTQ+ ที่เห็นในผังด้านบนคือฝ่ายที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อจัด Pride month และโปรโมท SI-pride clinic เพราะอยากลบภาพจำว่าศิริราช conservative

ปีแรกของชมรม (2567–2568) มีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ First Meet เปิดตัวชมรม ไปจนถึง Workshop หัตถการพื้นฐาน พานักศึกษาเข้าดูงานใน OR จริง กิจกรรม Pride month และปิดท้ายด้วยงานวิชาการที่เชิญวิทยากรต่างประเทศ — แต่ละงานเป็นก้าวเล็กๆ ที่ต่อยอดจนชมรมมีตัวตนจริง ไม่ใช่แค่ไอเดียในหัวอีกต่อไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้ — What I Took From It

การก่อตั้งชมรมสอนเรื่อง systems thinking มากกว่าที่คิด — ไม่ใช่แค่จัดงานให้สนุก แต่ต้องออกแบบให้ระบบเดินต่อได้เองในระยะยาว

ภาวะผู้นำ — ประธานชมรม SIOGC
Leadership — SIOGC President & Founder

ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานชมรม SIOGC ผมได้ทำงานใกล้ชิดกับทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์แพทย์ในภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเห็นว่าบุคลากรในสาขานี้มีไฟพร้อมเปิดรับฟังความเห็นจากนักศึกษาและแพทย์รุ่นใหม่อยู่เสมอ
นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่าสูติ-นรีเวชเป็นพื้นที่ที่แพทย์รุ่นใหม่อย่างผมสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้จริง ตลอดปีที่ผ่านมา ผมรับผิดชอบวางแนวคิด ประสานวิทยากร และควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมชุมชนของชมรมทั้งหมด ตั้งแต่งานเปิดตัวชมรมครั้งแรกไปจนถึงโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน

ไทม์ไลน์กิจกรรม — Key Milestones

2567 (ชั้นปีที่ 4) · ก่อตั้งชมรม SIOGC
เริ่มวางแผนกิจกรรมแรกของชมรม

2568 · SIOGC First Meet & Workshop ครั้งที่ 1
งานเปิดตัวชมรมครั้งแรก และเวิร์กช็อปหัตถการพื้นฐาน OB/GYN 4 สถานี

2568 · Siriraj Open House & เบิกฟ้าชมรม Booth
ออกแบบและควบคุมดูแลบูธแนะนำชมรมในสองงานใหญ่ของคณะ

2568 · Resident Playbook Movie Night & Annual Conference Campaign
แนะแนวเส้นทางแพทย์ประจำบ้าน และชวนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

2568 · LGBTQ+ Awareness & Pride Month Movie Night
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ ในบริบททางการแพทย์

2568 · HPV Self-Test Project & ก่อตั้ง Research Club Unit
ร่วมกับ พม. จัดตรวจคัดกรอง HPV ในชุมชน และก่อตั้งหน่วยวิจัยนักศึกษาสูติ-นรีเวช

Leadership — SIOGC President & Founder





SIOGC First Meet — จุดเริ่มต้นของชมรม (2025)

- งานเปิดตัวชมรม SIOGC ครั้งแรก เชิญแพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวชมาพูดคุยเรื่องแรงบันดาลใจและเส้นทางสู่สาขา OB/GYN
- เป็นประธานและผู้ริเริ่มจัดกิจกรรมนี้ตั้งแต่ต้น ตั้งแต่วางคอนเซปต์งานจนถึงประสานงานกับวิทยากร
- เป้าหมายคือให้รุ่นน้องได้สัมผัสและรู้จักสาขา OB/GYN ตั้งแต่ชั้นปีต้น ก่อนต้องตัดสินใจเลือกสาขา





Siriraj Open House — 3 Clinical Skills Workshops (2025)

- ออกแบบและควบคุมดูแลบูธกิจกรรม 3 สถานี: Normal Labor, IUD/ICD insertion และ PV & Pap smear
- ให้น้องนักศึกษาแพทย์และผู้เข้าชมงานได้ลองฝึกหัตถการพื้นฐานทาง OB/GYN บนหุ่นจำลอง
- เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของชมรมที่ทำต่อเนื่องเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสาขานี้ให้กว้างขึ้นในหมู่นักศึกษาแพทย์



Resident Playbook Movie Night (2568)

- กิจกรรมภาพยนตร์เชิงโต้ตอบ สอดแทรกความรู้ระดับ high-yield สำหรับเตรียมสอบ
- ออกแบบเนื้อหาให้เชื่อมโยงกับเคสจริงในสูติ-นรีเวชที่พบบ่อย
- จัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้รุ่นน้องก่อนช่วงสอบและก่อนขึ้นวอร์ด

Leadership — SIOGC President & Founder



HPV Self-Test Community Project (2568)

- ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง HPV ในชุมชน
- ให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง (HPV self-test)
- ขยายการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองไปยังกลุ่มที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ยาก



Pride Month Movie Night (2568)

- ฉายภาพยนตร์ Heartstopper พร้อมเซสชันพูดคุยเรื่อง hormonal therapy และประเด็นสุขภาพ LGBTQ+
- สร้างพื้นที่เปิดกว้างให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจมิติสุขภาพที่หลากหลายมากขึ้น

Leadership — SIOGC President & Founder



1st SIOGC Workshop (2568)

- เวิร์กช็อปหัตถการพื้นฐาน OB/GYN 4 สถานี: Normal Labor, Perineorrhaphy, Contraceptives & IUD insertion, PV & Pap smear
- เปิดให้รุ่นน้องนักศึกษาแพทย์ฝึกหัตถการจริงบนหุ่นจำลองภายใต้การดูแลของวิทยากร
- เป็นเวิร์กช็อปแรกที่ชมรมจัดขึ้นเอง วางรากฐานให้กิจกรรมเชิงหัตถการต่อเนื่องในปีถัดมา

กิจกรรมอื่น ๆ ที่ริเริ่มในฐานะประธานชมรม

เบิกฟ้าชมรม Booth (2568)
จัดบูธแนะนำชมรมและกิจกรรมให้นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่

Annual Conference Campaign (2568)
ชวนนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยสูตินรีเวชฯ

LGBTQ+ Awareness Activities
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ ในบริบททางการแพทย์

OB/GYN Student Research Club Unit
ก่อตั้งหน่วยงานกิจการสำหรับนักศึกษาแพทย์ภายใต้ชมรม SIOGC



International & Clinical Exposure

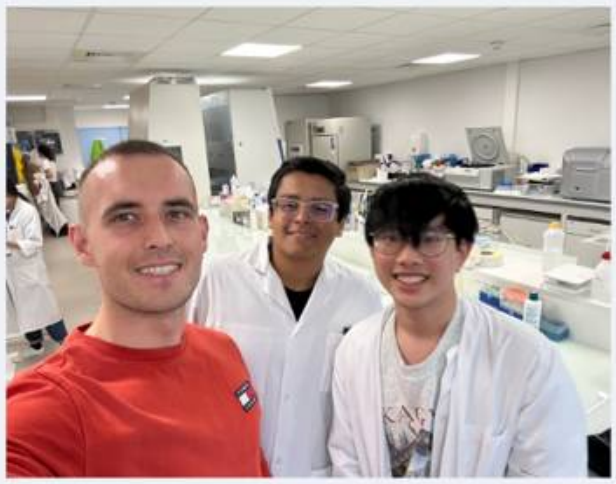
Overview

2023

เข้าร่วม IFMSA Research Exchange ที่ Marseille เริ่มต้นเส้นทางแลกเปลี่ยนนานาชาติ

2025–2026

หมุนเวียนคลินิกที่สิงคโปร์ (NUH/NUS) และอิเล็กทีฟ OB/GYN ในไทย



6
Total Experiences

3
Countries Visited

2027
Next: Duke University

เส้นทางเริ่มจากงานวิจัยแลกเปลี่ยนที่ฝรั่งเศสตอนปี 4 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ออกไปเห็นระบบสุขภาพนอกประเทศ ก่อนจะขยับมาเป็นงานคลินิกจริงที่สิงคโปร์และงานวิจัยสาธารณสุขที่ลาว ตามด้วยการหมุนเวียนอิเล็กทีฟ OB/GYN ในโรงเรียนแพทย์อื่นของไทยเพื่อเทียบระบบใกล้บ้านก่อน แต่ละก้าวขยายมุมมองไปทีละชั้น — จากดูงานอย่างเดียว ไปสู่ลงมือทำงานคลินิกจริง และสุดท้ายคือทำงานวิจัยที่ต้องเข้าใจบริบทของประเทศอื่นอย่างลึก

Key Experiences

- **1. Marseille, France — IFMSA Research Exchange (2023)**
  งานวิจัยระยะสั้นที่ Aix-Marseille Université จุดเริ่มต้นของความสนใจด้าน global health
- **2. NUH, Singapore — Clinical Exchange (2025)**
  หมุนเวียนดูงานผ่าตัด Ortho & Plastic Surgery ในระบบบริการสุขภาพสิงคโปร์
- **3. NUS, Singapore — Public Health Research Internship (2025)**
  Stakeholder analysis ของ HPV vaccination landscape ในลาว ที่ Saw Swee Hock School of Public Health
- **4. Prince of Songkla University — OB/GYN Elective (2026)**
  อิเล็กทีฟสูติ-นรีเวช 2 สัปดาห์ เห็นการดูแลผู้ป่วยในบริบทโรงเรียนแพทย์ภูมิภาค
- **5. Thammasat University — OB/GYN Elective (2026)**
  อิเล็กทีฟสูติ-นรีเวช 2 สัปดาห์ เปรียบเทียบระบบการเรียนการสอนและการดูแลผู้ป่วย
- **6. Duke University — OB/GYN Elective (2027, pending)**
  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศิริราชไปแลกเปลี่ยนทางคลินิก เมษายน 2027

International Experience — Marseille, France



IFMSA Research Exchange Program — Aix-Marseille Université (2023)

• โครงการแลกเปลี่ยนงานวิจัยของ IFMSA ที่ Aix-Marseille Université ประเทศฝรั่งเศส เมษายน–พฤษภาคม 2023

• ทำงานร่วมกับทีมวิจัยในระบบมหาวิทยาลัย–โรงพยาบาลของฝรั่งเศส และเข้าสังเกตการณ์การดูแลผู้ป่วย

• เป็นการออกไปเรียนรู้นอกประเทศครั้งแรก จุดตั้งต้นของความสนใจด้าน global health และงานแลกเปลี่ยนนานาชาติในเวลาต่อมา

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ในระบบโรงพยาบาลของประเทศอื่นแบบไม่มีใครคอยบอกว่าอะไรคือเรื่องปกติ — ต้องสังเกตเองว่าทำไมทีมที่นี่ถึงตัดสินใจแบบนี้ ไม่ใช่แบบที่คุ้นเคยจากศิริราช กลับมาไทยปีเดียวกันนั้นเองที่ผมชวนเพื่อนก่อตั้งชมรม Global Health ของศิริราช เพราะอยากมีพื้นที่ให้นักศึกษาแพทย์คนอื่นได้ตั้งคำถามแบบเดียวกันบ้าง

International Experience — NUH, Singapore



Clinical Exchange — Orthopedic & Plastic Surgery, NUH / NUS (2025)

• หมุนเวียนดูงานทางคลินิก 2 สาขา — Orthopedic surgery และ Plastic surgery ที่ National University Hospital (NUH), NUS สิงคโปร์ กุมภาพันธ์–มีนาคม 2025
• เข้าห้องผ่าตัด ward round และ OPD ร่วมกับทีมแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์ในระบบของสิงคโปร์
• เห็นการจัด workflow การส่งต่อผู้ป่วย และการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่

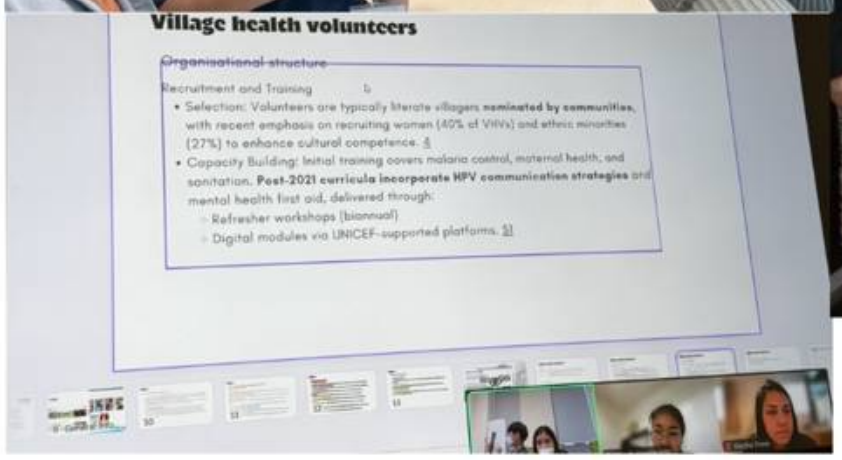
สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

สิงคโปร์มี resource เกินกว่าที่ศิริราชจะเทียบได้ในหลายจุด แต่สิ่งที่แปลกใจคือ case ที่ complications เยอะบางเคสกลับจัดการได้ไม่ต่างจากที่เราทำ — ตัวแปรที่ต่างจริงๆ คือการสื่อสารส่งต่องานระหว่างทีมที่ชัดเจนกว่ามาก ไม่ใช่แค่เครื่องมือ เป็นมุมมองที่ผมเอากลับมาใช้เวลาอยู่เวรที่ศิริราช โดยเฉพาะตอนต้องส่งต่อ case ข้ามทีม

International Experience — Public Health, NUS







Public Health Research Internship — Saw Swee Hock, NUS (2025)

• ฝึกงานวิจัยสาธารณสุข 2 สัปดาห์ ที่ Saw Swee Hock School of Public Health, NUS ภายใต้การดูแลของ Assoc. Prof. Kiesha Prem
• ทำ stakeholder analysis ของ HPV vaccination landscape ในประเทศลาว
• เข้าพบอาจารย์ด้วยตัวเองหลังฟังบรรยายในงาน PMAC จนได้รับโอกาสฝึกงาน (พบอาจารย์ครั้งแรก 18 มีนาคม 2025)

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

ตอนทำ stakeholder analysis เรื่อง HPV vaccination ในลาว สิ่งที่งงที่สุดไม่ใช่ตัวเลข coverage ที่ต่ำ แต่คือแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองปัญหาเดียวกันคนละมุม บางหน่วยโฟกัสที่งบประมาณ บางหน่วยโฟกัสที่ความเชื่อทางวัฒนธรรม กลับมาไทยเรื่องนี้ยังติดอยู่ในหัว จนตอนที่ชมรมทำโครงการ HPV self-test ในชุมชน ผมเลยพยายามผลักดันให้เก็บข้อมูลความเข้าใจของชุมชนควบคู่ไปด้วย ไม่ใช่แค่ตัวเลขคนมาตรวจ

HPV Vaccination — นโยบายที่ดีอาจไม่เดิน

HIGHLIGHT PROJECT · International & Clinical Exposure · Public Health Research Internship, NUS

หลังจากติดต่อ Dr. Kiesha Prem จากงาน PMAC ผมได้ไปทำ elective ด้าน public health ที่ NUS และโปรเจกต์ย่อยเรื่องส่งเสริมวัคซีน HPV ที่ลาว

งานหลักคือทำ stakeholder analysis ว่าใครบ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับการเพิ่ม coverage วัคซีน HPV และแต่ละฝ่ายมองปัญหาเดียวกันอย่างไร

“สิ่งที่งงที่สุดไม่ใช่ตัวเลข coverage ที่ต่ำ แต่คือเราตกลงกันไม่ได้เลยว่าปัญหาคืออะไร”

บางหน่วยงานโฟกัสที่งบประมาณ บางหน่วยโฟกัสที่ความเชื่อทางวัฒนธรรม บางหน่วยโฟกัสระบบขนส่งวัคซีน หน่วยงานเดียวกันที่คุยกันไม่รู้เรื่อง

กลับมาไทย เรื่องนี้ยังติดอยู่ในหัว จนตอนที่ชมรมทำโครงการ HPV self-test ในชุมชน ผมเลยพยายามผลักดันให้เก็บข้อมูลความเข้าใจของชุมชนควบคู่ไปด้วย ไม่ใช่แค่นับจำนวนคนมาตรวจ

“อะไรที่เขากลัว สำคัญพอๆ กับการรู้ว่าอะไรได้ผล”

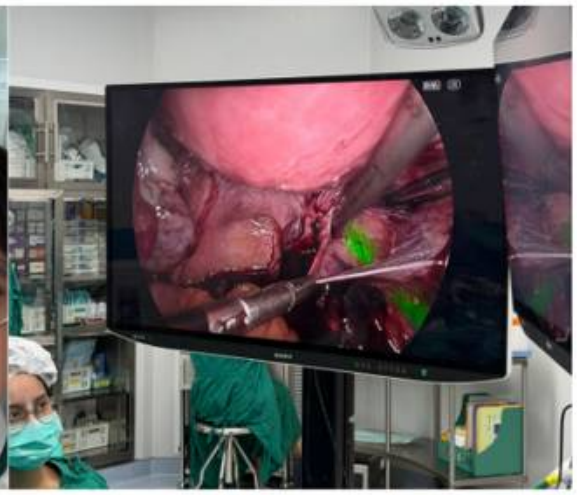
KEY MESSAGE

Evidence-based policy อย่างเดียวไม่พอ — นโยบายจะเดินได้ต้องมีคนที่เชื่อในมันด้วย

Clinical Electives — OB/GYN (2026)







Prince of Songkla University — OB/GYN Elective (2026)

- อิเล็กทีฟสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 สัปดาห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสูติ-นรีเวช เห็นความต่างของ case mix และระบบส่งต่อในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

เคสที่เห็นบ่อยกว่าศิริราชคือ complications จากการฝากครรภ์ไม่สม่ำเสมอ เพราะคนไข้หลายคนเดินทางจากอำเภอรอบนอกมาไกล ระบบส่งต่อที่นี่จึงต้องคิดเรื่องระยะทางเป็นตัวแปรหลักตั้งแต่แรก ไม่ใช่แค่ severity ของโรค





Thammasat University — OB/GYN Elective (2026)

- อิเล็กทีฟสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 สัปดาห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เปรียบเทียบระบบการเรียนการสอนและแนวทางการดูแลผู้ป่วยกับศิริราช เห็นมุมมองการฝึกสูติ-นรีเวชที่หลากหลายขึ้น

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

ธรรมศาสตร์ใช้ระบบ small-group teaching ที่ใกล้ชิดกว่าศิริราชมาก นักศึกษาต่อเคสได้ลึกกว่าเพราะกลุ่มเล็ก แต่ก็เห็นข้อจำกัดว่าจำนวนเคสที่หมุนเวียนได้น้อยกว่า เป็นการเทียบที่ทำให้เข้าใจว่าโครงสร้างของแต่ละที่ (ขนาดคณะ จำนวนนักศึกษา) กำหนดวิธีสอนพอๆ กับปรัชญาการศึกษา

International & Clinical Exposure — Additional Activities

กิจกรรมและบทบาทเสริมที่ยังไม่มีภาพประกอบ

กิจกรรมเพิ่มเติม — Additional Exchanges & Roles

Duke University — OB/GYN Elective (2027, pending)
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนศิริราชไปแลกเปลี่ยนทางคลินิก เมษายน 2027

OB/GYN Elective — ศูนย์กาญจนาภิเษก (2569)
อิเล็กทีฟสูติ-นรีเวช 2 สัปดาห์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 18-30 ต.ค. 2569

OB/GYN Elective — ศิริราชพยาบาล (2569)
อิเล็กทีฟสูติ-นรีเวชภายในสถาบัน 16-27 มี.ค. 2569

Lore-Out Selection Team, SCORE IFMSA (2566)
[redacted]คัดเลือกนักศึกษาแพทย์เข้าโครงการแลกเปลี่ยนวิจัยต่างประเทศ

Global Health & Public Health Systems

Overview

2023–ปัจจุบัน

VP & Co-founder ชมรม Global Health ของนักศึกษาแพทย์ศิริราช

2025–2026

เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม PMAC ต่อเนื่อง 2 ปี ในฐานะ Observer & Vice President



7
Global Health Initiatives

2
PMAC Years Attended

2023
VP Since

ในฐานะรองประธานชมรม Global Health และตัวแทนเข้าร่วมประชุม PMAC ผมได้เรียนรู้ว่าปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนต้องอาศัยมุมมองเชิงระบบ ไม่ใช่แค่ความรู้ทางคลินิกเพียงอย่างเดียว การได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ทำให้ผมเห็นภาพใหญ่ของระบบสุขภาพ และตระหนักว่าตัวเองเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปทีละก้าว

Key Initiatives

- **1. VP & Co-founder — Siriraj Global Health Club (2023–ปัจจุบัน)**
  ร่วมก่อตั้งและบริหารชมรม Global Health ของนักศึกษาแพทย์ศิริราช
- **2. Chair — Global Health Case Competition (PMAC side-event, 2024)**
  ดูแลการจัดแข่งขันและกระบวนการคัดเลือกทีมนักศึกษา
- **3. Indo-Pacific Case Competition — University of Melbourne (2024)**
  รับผิดชอบการคัดเลือกทีมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค
- **4. PMAC 2025 & 2026 — Observer & Vice President**
  รองประธาน PMAC Global Health Case Competition ติดต่อกัน 2 ปี
- **5. President — Siriraj Global Health Case Competition Unit (IPGHCC)**
  ก่อตั้งและดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบจัด case competition ด้าน global health โดยเฉพาะ
- **6. Field Work — สสจ.พิจิตร**
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์หยุดเผาป่าร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
- **7. Co-Founder, Issara Project — Community Health (2025)**
  ร่วมกับ Sri Hope Club และ NUS จัด Hypertension Screening Program ในชุมชน

Global Health — PMAC 2025



PMAC 2025 — Observer & Vice President of PMAC Global health case competition (Jan 2025)

- PMAC (Prince Mahidol Award Conference) คือการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน global health จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
- ในฐานะรองประธานชมรม Global Health รับผิดชอบ PMAC Global Health Case Competition 2025 (side-event) ในส่ววนของ Case building, Competition part ผมมีหน้ามี่บริหารทีม ประเมิน KPI/OKR รายเดือน ไปจนถึงออกแบบโจทย์และหา judge
- ปีนี้มีทีมเข้าร่วม 6 ประเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 15 ทีม

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

นอกจากงาน side event ผมยังได้เข้าร่วม field trip ของงาน main conference ซึ่งมีคุณค่าต่อผมมาก ได้ฟังไอเดียเรื่อง AI ในวงการแพทย์ เช่น เทคโนโลยีวิเคราะห์ genomic ด้วย AI จากประเทศจีน ที่จะทำให้ whole exome sequencing และ precision medicine เข้าถึงได้มากขึ้นในอนาคต

จุดเปลี่ยนสำคัญคือการได้ฟัง Dr. Kiesha Prem บรรยายเรื่องการใช้ AI model วิจัยรูปแบบการแพร่ระบาดของ COVID และพูดถึงโครงการส่งเสริมวัคซีน HPV ที่กำลังทำอยู่ ผมสนใจมากจึงติดต่ออาจารย์โดยตรง จนได้ไปทำ elective โปรเจกต์ย่อยเรื่องส่งเสริมวัคซีน HPV ที่ลาว 2 สัปดาห์ในเวลาต่อมา

ประสบการณ์นี้เปิดโลกทั้งเรื่อง AI ทางการแพทย์ เครือข่ายคนทำงาน global health ระดับนานาชาติ และแรงบันดาลใจกลับมาทำวิจัยต่อ แต่ที่สำคัญที่สุดคือทำให้ผมเห็นว่าตัวเองมีความสามารถมากพอ และโอกาสไม่ใช่แค่โชค — ถ้าเราพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่พร้อม โอกาสจะตามมา และเราต้องกล้าคว้ามันไว้

Global Health — PMAC 2026



PMAC 2026 — Observer & Vice President (Jan 2026)

- ปีนี้ชมรมได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน PMAC Global Health Case Competition 2026 แต่เพียงผู้เดียว — ขอบเขตงานกว้างและละเอียดขึ้นจากปีก่อน
- นำ feedback ข้อบกพร่อง และ near-miss events จากปีที่แล้วมาออกแบบ workflow ใหม่ให้สมบูรณ์ขึ้น
- ตั้งเป้าหมายร่วมกับประธานชมรมเรื่อง standardization เพื่อผลักดันให้งานเป็น international มากที่สุด ยกระดับมาตรฐาน case question, judging system, ceremony และ venue management
- ปรับปรุง workflow ให้ lean ขึ้น วางโครงสร้างทีมทำงานใหม่ และส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องที่มา shadow งาน

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

ปีนี้ PMAC จัดขึ้นภายใต้ธีม ‘Navigating Global Demographic Transition through Innovative Policy: An Equity-Centered Approach’ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ทั้งสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดที่ลดลง ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพทั่วโลก ผมสนใจประเด็นอัตราการเกิดที่ลดลงเป็นพิเศษ เพราะเชื่อมโยงโดยตรงกับงานด้านสูติ-นรีเวชที่กำลังศึกษาอยู่ — ระบบสุขภาพจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับทั้งการดูแลภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวในโลกที่ประชากรเกิดใหม่น้อยลง

การได้กลับมารับผิดชอบงานนี้เป็นปีที่สอง ทำให้เห็นความแตกต่างชัดเจนจากปีแรก — ปีที่แล้วผมเรียนรู้จากการลงมือทำ ปีนี้ต้องคิดเชิงระบบมากขึ้น มองว่าอะไรที่เคยพลาดและจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เป็นการฝึกภาวะผู้นำแบบที่ไม่ใช่แค่บริหารงานเฉพาะหน้า แต่ต้องออกแบบระบบให้ยั่งยืนสำหรับทีมรุ่นต่อไป

PMAC — โอกาสไม่ใช่แค่โชค

HIGHLIGHT PROJECT · Global Health · Vice President, PMAC Global Health Case Competition

PMAC คือการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน global health จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ผมเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะรองประธานชมรม Global Health รับผิดชอบ PMAC Global Health Case Competition สองปีติด

ปี 2025 ผมดูแลส่วน case building และ competition — บริหารทีม ประเมิน KPI/OKR รายเดือน ออกแบบโจทย์และหา judge ปีนั้นมีทีมเข้าร่วม 6 ประเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 15 ทีม

แต่สิ่งที่เปลี่ยนเส้นทางผมจริงๆ เกิดขึ้นนอกงาน side event ผมไปฟัง Dr. Kiesha Prem บรรยายเรื่องการใช้ AI วิจัยการแพร่ระบาดของ COVID และพูดถึงโครงการส่งเสริมวัคซีน HPV ที่กำลังทำอยู่

ผมสนใจมากจนติดต่ออาจารย์โดยตรงหลังจบงาน จนได้ไปทำ elective โปรเจกต์ส่งเสริมวัคซีน HPV ที่ลาว 2 สัปดาห์ในเวลาต่อมา

“โอกาสไม่ใช่แค่โชค ถ้าเราพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่พร้อม โอกาสจะตามมา และเราต้องกล้าคว้ามันไว้”

ปี 2026 ชมรมได้รับมอบหมายให้ดูแลงานนี้แต่เพียงผู้เดียว ผมเอา feedback และ near-miss events จากปีก่อนมาออกแบบ workflow ใหม่ ผลักดัน standardization ทั้ง case question, judging system และ venue management

“ปีแรกผมเรียนจากการลงมือทำ ปีที่สองต้องคิดเชิงระบบ — ออกแบบให้มันเดินต่อได้โดยไม่ต้องมีผม”

KEY MESSAGE

สิ่งที่ได้จากวันนั้นไม่ใช่ความรู้ แต่คือความเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถมากพอ และกล้าคว้าโอกาสเมื่อมันมาถึง

Global Health — CURASI Capacity Building









CURASI — Global Health Capacity Building (จุฬาฯ x รามาธิบดี x ศิริราช)

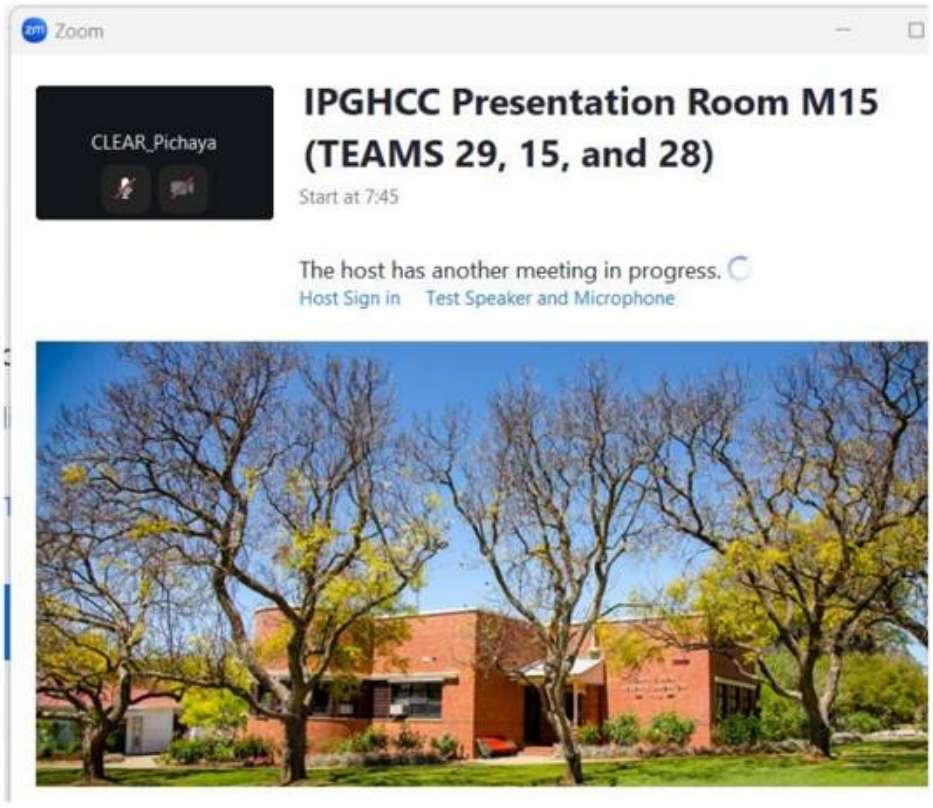
- CURASI Global Health Capacity Building เป็นงานที่ชมรม Siriraj Global Health ริเริ่มขึ้นเอง โดยประสานงานกับชมรม Global Health ของจุฬาฯ และรามาธิบดี (CU + RA + SI)
- จุดเริ่มต้นมาจากการเห็นว่านักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่า global health คืออะไรและสำคัญอย่างไร การเข้าใจบริบทนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการแก้ปัญหาระบบสุขภาพไทย
- เชิญ อ.เจษฎ์ เลขาธิการ สปสช. มาบรรยายเรื่อง UHC ในไทยเทียบกับบริบทนานาชาติ พร้อมวิทยากรอีก 2 ท่าน
- มี case simulation workshop ให้นักศึกษาแพทย์จากทั้ง 3 สถาบันร่วมกันแก้โจทย์จำลอง

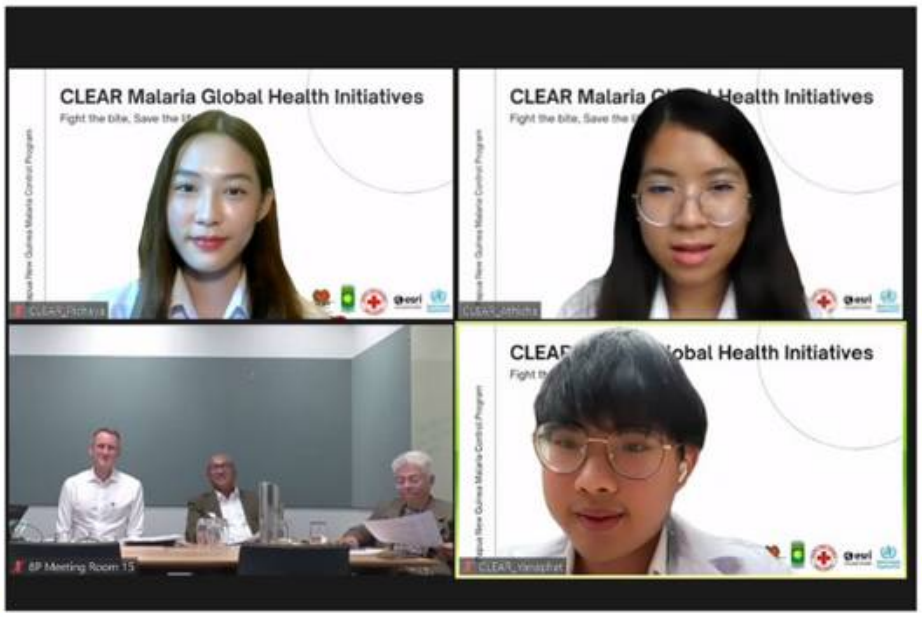
สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

ผมรับผิดชอบดูแลส่วน workshop และการบริหารจัดการ รวมถึงเก็บ feedback แบบ active จากวิทยากร ทีมทำงาน และผู้เข้าร่วมตลอดงาน

การจัดงานร่วมกับอีก 2 สถาบันสอนให้เห็นความท้าทายของการประสานงานข้ามองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานต่างกัน แต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้นักศึกษาแพทย์จากทั้ง 3 ที่ได้เห็นภาพรวมของปัญหาสุขภาพที่ใหญ่กว่าห้องเรียนของตัวเอง

Global Health — IPGHCC Competition





President — Siriraj Global Health Case Competition Unit

- ก่อตั้งและดูแลหน่วยงานของชมรม SIOGC ที่รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน case competition ด้าน global health โดยเฉพาะ
- ดูแลการเข้าร่วมแข่งขัน International Public and Global Health Case Competition (IPGHCC)
- ประสานงานทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราชในการเตรียมตัวและเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

การดูแลหน่วยงานนี้ทำให้ผมเห็นภาพรวมของงาน case competition ตั้งแต่การออกแบบโจทย์ การคัดเลือกหัวข้อ ไปจนถึงการประสานงานกับทีมนานาชาติ เป็นประสบการณ์การจัดการที่ต่อเนื่องจากการเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขัน

Global Health — Pichit Elective

ภาวะผู้นำ นโยบาย และธรรมาภิบาลสาธารณสุข







- Courtesy call กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (นพ.วิสิษฐ์) — เปิดหัวข้อภาวะผู้นำและการสื่อสาร
- ฟังบรรยาย hierarchy กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปลัดกระทรวงถึงสาธารณสุขอำเภอ
- ศึกษาโครงการ One Province One Hospital — รวมทรัพยากรโรงพยาบาลทั้งจังหวัด
- ดูงานเหมืองทองอัครา — พลวัตภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน

สิ่งที่ประทับใจและได้กลับมา — What I Took From It

สิ่งที่ติดตัวมากที่สุดจาก 3 วันแรกคือความเข้าใจว่า character สำคัญกว่า personality ในการเป็นผู้นำ — และการโน้มน้าวสำคัญกว่าการสั่งการเสมอ การได้เห็น hierarchy ของกระทรวงสาธารณสุขทำให้เข้าใจว่าทำไมนโยบายที่ดีบนกระดาษถึงนำไปปฏิบัติจริงได้ยาก ไม่ใช่เพราะคนไม่ตั้งใจ แต่เพราะแต่ละชั้นมีบริบทและข้อจำกัดต่างกัน และ evidence-based policy อย่างเดียวไม่พอ ต้องมีแรงสนับสนุนทางการเมืองรองรับด้วยเสมอ

งานภาคสนามชุมชน — บวร (บ้าน วัด ราชการ)





- ร่วมกิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด ราชการ) ผ่านเครือข่ายวัดและ อสม.
- สังเกตการควบคุมโรค Strep suis ด้วยการสื่อสารเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

งานภาคสนามวันนี้สอนว่าในพื้นที่ชนบท วัดและ อสม. คือหัวใจของงานสาธารณสุขเชิงรุก เป็นสะพานเชื่อมนโยบายกับชุมชนที่มีประสิทธิภาพกว่าการสื่อสารจากส่วนกลางตรงๆ และการควบคุมโรคที่ดีต้องเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่ทำซ้ำวิธีเดิมโดยหวังผลต่าง สุขภาพไม่เคยแยกขาดจากสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา

Global Health — Pichit, Community

ท่าฬ่อโมเดล — ความยากจน ยาเสพติด และการรณรงค์หยุดเผาป่า





- ประชุมโครงการนำร่องขจัดความยากจนที่ท่าฬ่อ ร่วมกับนายอำเภอ นายกเทศบาล เจ้าอาวาส และ อสม.
- ร่วมรณรงค์หยุดเผาป่ากับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เดียวกัน
- สังเกตการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีท่าทีลบเข้าสู่บทสนทนาด้วยการโน้มน้าว
- เยี่ยมบ้าน 2 หลัง — ครอบครัวรายได้ไม่มั่นคง และผู้ป่วยติดยาเสพติด

สิ่งที่ประทับใจและได้กลับมา — What I Took From It

วันนี้เป็นวันที่ประทับใจที่สุดของ elective นี้ — สิ่งที่จำได้แม่นคือคำพูดของอาจารย์วิสิษฐ์ที่ว่า "ต้องทุ่มความพยายามไปที่จุดแข็งของเรา ไม่ใช่ทุ่มไปกับการปิดจุดอ่อนทั้งหมด" ซึ่งพลิกบรรยากาศห้องประชุมที่ตึงเครียดให้ทุกคนเริ่มเชื่อในโครงการได้จริง การเยี่ยมบ้านทั้งสองหลังตอกย้ำว่านโยบายที่ดีต้องเข้าใจบริบทและข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติจริงเสมอ และปัญหายาเสพติดลึกกว่าที่คิด มีเพียง 10% ที่เลิกได้จริง — ต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเศรษฐกิจ ความยากจน และครอบครัว ไม่ใช่ที่ปลายเหตุ

Inspiration Talk — โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ







- บรรยายสร้างแรงบันดาลใจนักเรียนเรื่องคุณค่าของการศึกษา
- ปรับเนื้อหาให้เข้ากับบริบทนักเรียน โดยยกตัวอย่างจากเพื่อนร่วมทีมที่พื้นเพใกล้เคียงแทนประสบการณ์ตัวเอง
- ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการนั่งสะท้อนร่วมกับอาจารย์วิสิษฐ์

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

การพูดครั้งนี้สอนว่าการสื่อสารต้องปรับให้เข้ากับผู้ฟังเสมอ ไม่ใช่พูดจากมุมของตัวเอง — การเลือกยกตัวอย่างจากคนที่มีพื้นเพใกล้เคียงผู้ฟังมากกว่าประสบการณ์ตัวเอง ทำให้ข้อความเข้าถึงได้จริง ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นว่า "ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์" — soft skills สำคัญพอๆ กับ clinical skills เสมอ

Global Health — Additional Activities

กิจกรรมและบทบาทเสริมที่ยังไม่มีภาพประกอบ

กิจกรรมเพิ่มเติม — Additional Initiatives & Roles

Indo-Pacific GH Case Competition — Melbourne (2567)

เข้าร่วมแข่งขันในฐานะตัวแทนที่คัดเลือกเองจาก University of Melbourne

GH Capacity Building (CU x RA x SI) (2567)

กรรมการจัดงาน 5 ต.ค. จุฬาฯ และ 9 พ.ย. ศิริราช

BDMS Field Trip — PMAC 2025 (2568)

ศึกษาดูงาน Exploring AI Healthcare Ecosystem in Thailand

ผู้ริเริ่ม Health Management Elective Unit

วางแนวทางอิเล็กทีฟด้าน Global Health ให้รุ่นน้อง

Conferences & Symposium





33rd Congress of the Thai Society for Reproductive Medicine (TSRM), 2026

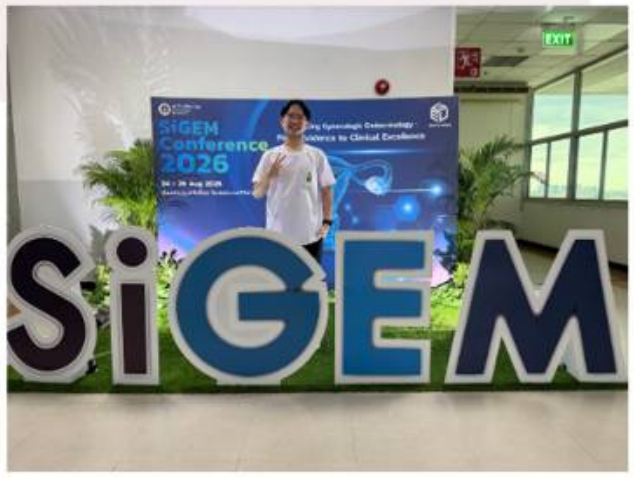




46th RCOST Annual Meeting, 2024

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

การเข้าร่วมประชุมวิชาการสูติ-นรีเวชระดับชาติทำให้เห็นความก้าวหน้าของงานวิจัยและเวชปฏิบัติในสาขาสูติ-นรีเวชเวชกรรม เป็นแรงผลักดันให้ติดตามงานวิจัยของตัวเองอย่างต่อเนื่อง



Conferences & Symposium — Additional Activities

กิจกรรมและบทบาทเสริมที่ยังไม่มีภาพประกอบ

กิจกรรมเพิ่มเติม — Additional Courses & Seminars

CMU E-learning — OB/GYN for GP
สำเร็จหลักสูตรออนไลน์ด้านสูติ-นรีเวชสำหรับแพทย์ทั่วไป

สัมมนา Infertility Management (RTCOG)
Clinical Updates and Evidence-Based Practice · 22 ส.ค. 2569

สัมมนา Cesarean Scar Defect (RTCOG)
More Than a Scar: Understanding Cesarean Scar Defect · 22 ส.ค. 2569

สัมมนา Reproductive Medicine ครั้งที่ 22
จัดโดย RTCOG · 30 ต.ค. 2568

Community Service & Volunteer

Overview

2024–2025

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่สังขละบุรี กาญจนบุรี
จัดทำวีดีโอสอนการฉีดอินซูลิน

2025

ร่วมก่อตั้ง Issara Project และดำรงตำแหน่ง
เลขานุการ SISC



3
Volunteer Projects

2
Provinces Reached

2025
Latest: Issara Project

เริ่มจากงานอาสาแพทย์เคลื่อนที่ที่สังขละบุรีตอนปี 4 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เจอผู้ป่วยที่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้เลย ต้องหาวิธีอธิบายการฉีดอินซูลินผ่านล่ามและวีดีโอ จากจุดนั้นขยับมาเป็นงานร่วมกับ Issara Project และ HPV self-test ที่เป็นการออกแบบโครงการเองตั้งแต่ต้น ไม่ใช่แค่เข้าร่วม — แต่ละก้าวสอนเรื่องการเข้าถึงกลุ่มที่ระบบสุขภาพปกติมองข้ามไปคนละมุม

Key Highlights

- **1. Community Health Volunteer — สังขละบุรี (2024–2025)**
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และวีดีโอสอนการฉีดอินซูลิน
- **2. Co-Founder — Issara Project (2025)**
  ร่วมกับ Sri Hope Club และ NUS จัดโครงการคัดกรองความดันโลหิตสูง
- **3. HPV Self-Test Community Project**
  ร่วมกับ พม. เพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชน
- **4. Secretary — Siriraj Student Committee (SISC, 2025)**
  เลขานุการคณะกรรมการนักศึกษาศิริราช
- **5. Event Staff — Nice(2) Meet You Salaya (2023)**
  ร่วมทีมสตาฟกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
- **6. Event Staff — Siriraj Family Concert (2023)**
  ร่วมทีมสตาฟจัดการคอนเสิร์ตประจำปีของคณะ

Community Service — Issara Project











Co-Founder — Issara Project (2025)

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

ตอนวางแผนโครงการคัดกรองความดันร่วมกับ Si Hope Club และ NUS สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องวิชาการ แต่คือการตกลงกันเรื่องขั้นตอนทำงานที่แต่ละฝ่ายคุ้นเคยไม่เหมือนกัน กว่าจะเจอจังหวะทำงานร่วมกันได้ลงตัวก็ใช้เวลาปรับตัวพอสมควร เป็นบทเรียนเรื่องการประสานงานข้ามทีมที่ผมเอามาใช้ตอนดูแลงาน SIOGC ต่อ

Issara Project — บทเรียนจากการทำงานข้ามทีม

HIGHLIGHT PROJECT · Community Service · Co-Founder, Issara Project

Issara Project เป็นโครงการคัดกรองความดันโลหิตในชุมชนที่ผมร่วมก่อตั้งในปี 2025 ทำงานร่วมกับ Si Hope Club และนักศึกษาจาก NUS

สิ่งที่ผมคิดว่าจะยากตอนเริ่ม คือเรื่องวิชาการ — โปรโตคอลการวัด การส่งต่อผู้ป่วยที่ค่าผิดปกติ แต่พอลงมือจริง

“สิ่งที่ยากที่สุดกลับไม่ใช่เรื่องวิชาการเลย แต่คือการที่แต่ละฝ่ายคุ้นเคยกับขั้นตอนทำงานคนละแบบ”

ทีม NUS มีวิธีวางแผนและเก็บข้อมูลแบบหนึ่ง Si Hope Club มีจังหวะการทำงานอีกแบบส่วนทีมเราก็มีวิธีที่ใช้กันมาตลอด กว่าจะหาจังหวะร่วมกันได้ลงตัวใช้เวลาปรับตัวพอสมควร

“การยืนยันว่าวิธีของเราถูกไม่ได้ทำให้งานเดินเร็วขึ้น ต้องเข้าใจก่อนว่าอีกฝ่ายทำงานยังไง”

บทเรียนนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ Issara ตอนดูแลงาน SIOGC ต่อ ซึ่งต้องประสานทั้งอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และองค์กรภายนอก พบว่าหลักการเดียวกันใช้ซ้ำได้หมด

KEY MESSAGE

การประสานงานข้ามองค์กรต้องเริ่มจากเข้าใจว่าอีกฝ่ายทำงานยังไง ก่อนจะพยายามทำให้อีกฝ่ายทำแบบเรา

Community Service — Sangkhlaburi





Kong Mong Ta Health Promotion Campaign (2025)





Mobile Medical Unit — Ban Dong Yang Refugee Camp (2025)

ออกตรวจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และช่วยให้ความรู้ รวมทั้งจัดสต็อกยา บริเวณแคมป์ผู้ลี้ภัยบ้านดอนยาง ชุมชนผู้ลี้ภัยสงครามสัญชาติพม่าในหุบเขา





Health Promotion VDO (3 Dialects) & Outstanding Project Award

ทำวีดีโอ 3 ภาษา (ไทย มอญ พม่า) สอนการฉีดอินซูลินอย่างปลอดภัย ได้รับรางวัลผลงานโดดเด่น รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ

ตอนถ่ายวีดีโอ ปัญหาไม่ใช่แค่แปลภาษา แต่คือหาล่ามที่เข้าใจศัพท์ทางการแพทย์พอจะแปลให้ถูกต้อง สุดท้ายต้องนั่งอธิบายทีละขั้นตอนกับล่ามก่อนถ่ายจริง ถึงจะมั่นใจว่าคนไข้จะเข้าใจตรงกับที่เราตั้งใจสื่อสาร



Community Service — Other Activities





Secretary — Siriraj Student Committee (SISC), 2025





Event Staff — Nice(2) & Siriraj Family Concert (2023)

สิ่งที่ได้กลับมา — What I took from it

กิจกรรมนอกเหนือวิชาการเหล่านี้สอนให้ผมเรื่องการทำงานเป็นทีมและการดูแลรายละเอียดซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญไม่แพ้กับงานวิชาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะและสถาบันทำให้ผมรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมรุ่นและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนศิริราชอย่างแท้จริง

Community Service & Volunteer — Additional Activities

กิจกรรมและบทบาทเสริมที่ยังไม่มีภาพประกอบ

กิจกรรมเพิ่มเติม — Additional Activities & Roles

สมาชิกฝ่ายกิจกรรม — รับน้องข้ามฟาก (2566)
ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแพทย์ใหม่

คณะผู้จัดทำ VDO ส่งเสริม HPV Screening ร่วมกับ อ.ปนิชา (2568)
ผลิตสื่อวีดีโอให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV self-test